



産科婦人科学講義 産科手術・産科麻酔

名古屋市立大学産科婦人科助教
小笠原 桜

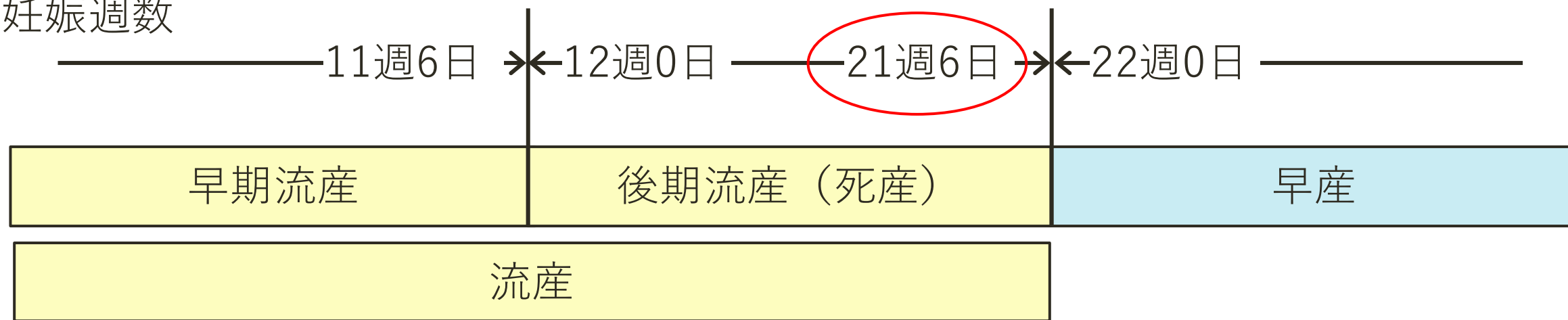
2026年7月6日4限

流産とは？

流産 = **妊娠21週6日まで**の妊娠の終了

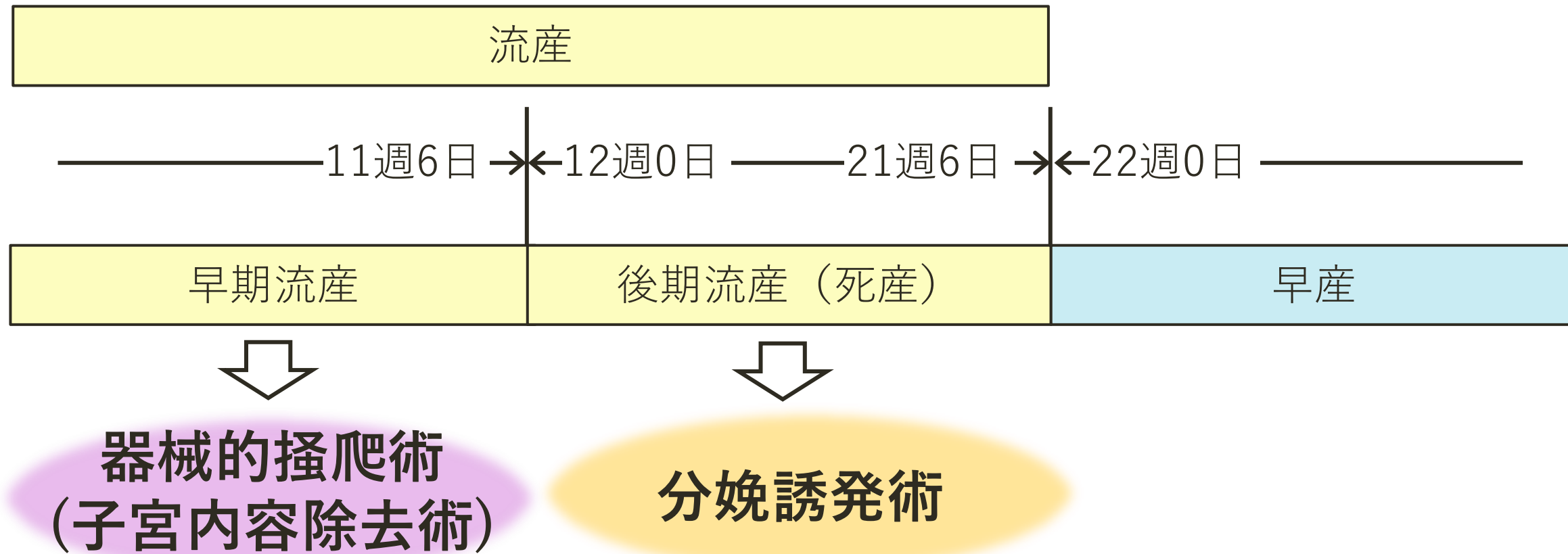
自然流産、人工流産

妊娠週数

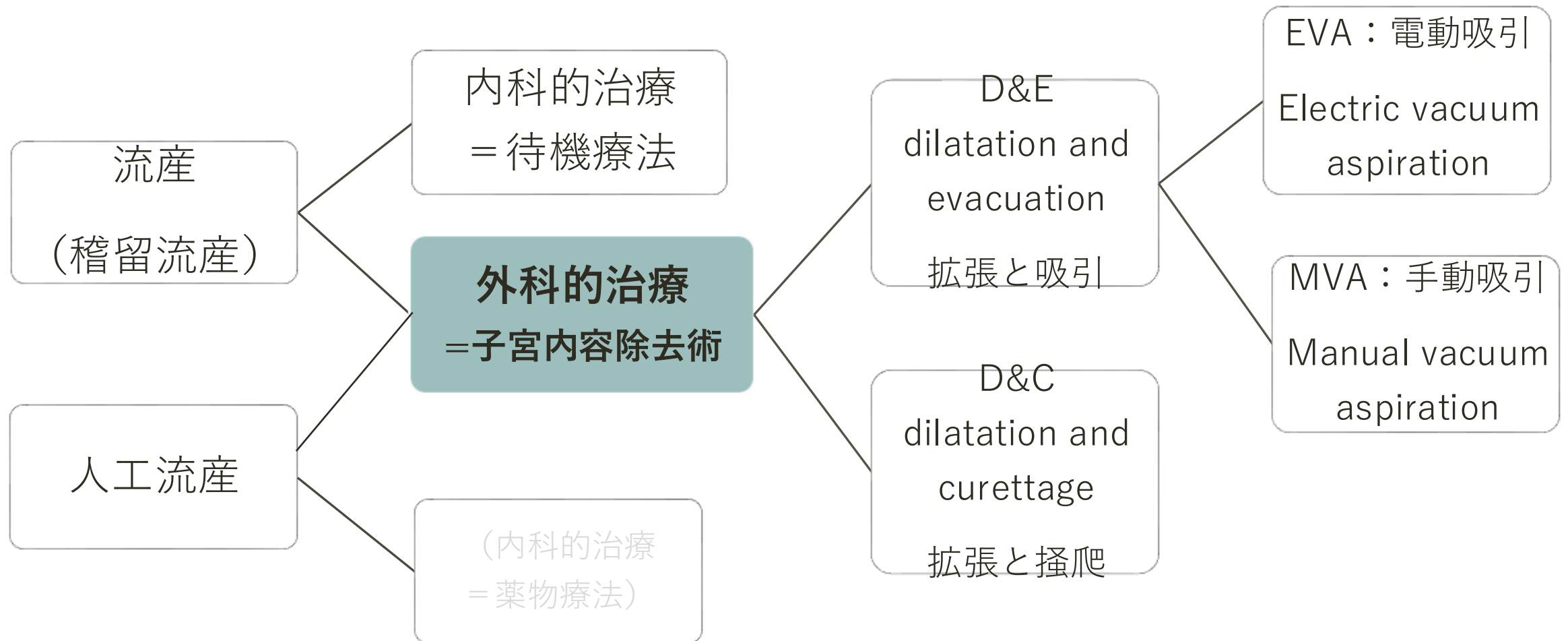


※妊娠12週以降の後期流産では死産証書の作成が必要

流産の手術法



早期（初期）流産の治療法



早期流産の手術法

“子宮内容除去術”

- (1) 子宮頸管拡張術
- (2) 子宮内容搔爬術

英語：Dilatation & Curettage
⇒“D&C ”
ドイツ語：Auskratzung(搔爬)
⇒AUS 「アウス」

早期流産の手術法 “子宮内容除去術”

(1) 子宮頸管拡張術

緩徐拡張法に続いて急速拡張法を行う

緩徐拡張法：水分吸収時の膨張

ラミナリア（海藻成分）



ダイラパン（加水分解ポリアクリロニトリル）

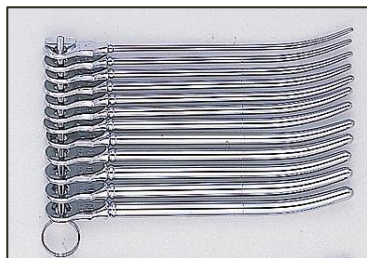
ラミセル（ポリビニールアルコール・コットン）



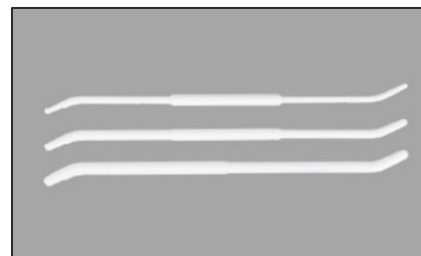
- ・通常無麻酔で行う
- ・数時間留置が必要

急速拡張法：物理的な頸管内からの圧迫

ヘガール頸管拡張器（金属：黄銅製Crメッキ）



ダイレーター（プラスチック）

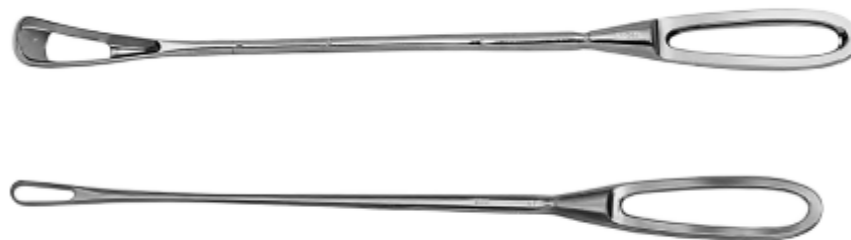
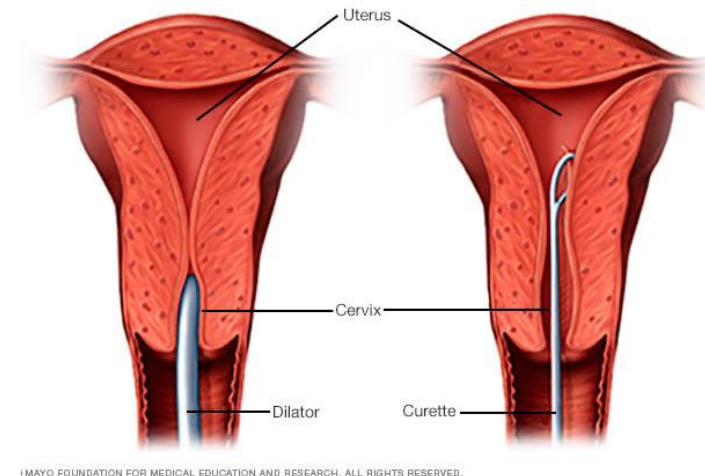


- ・急激な拡張は頸管裂傷の危険性がある

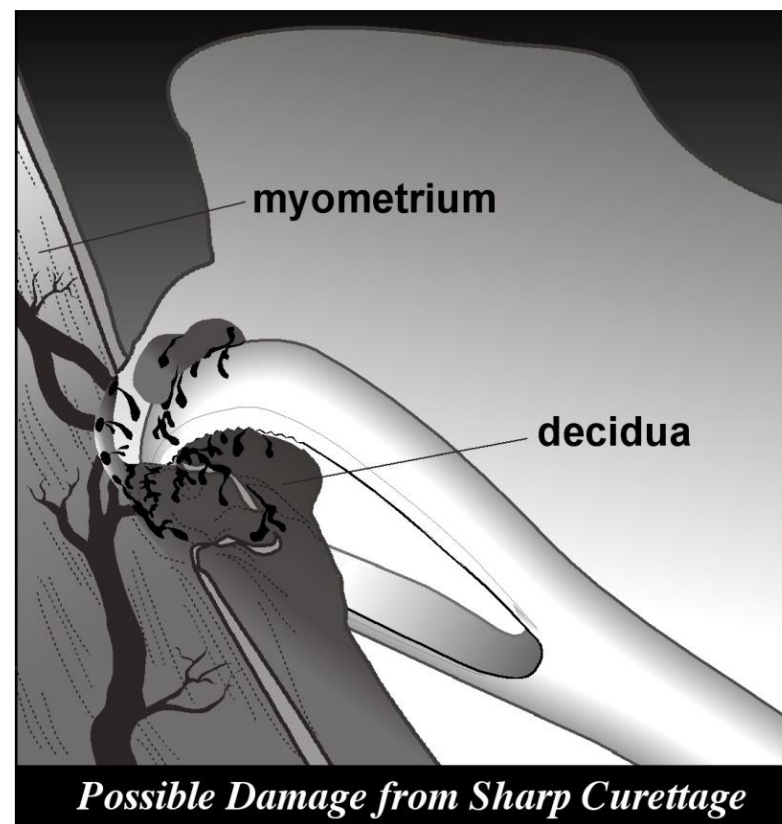
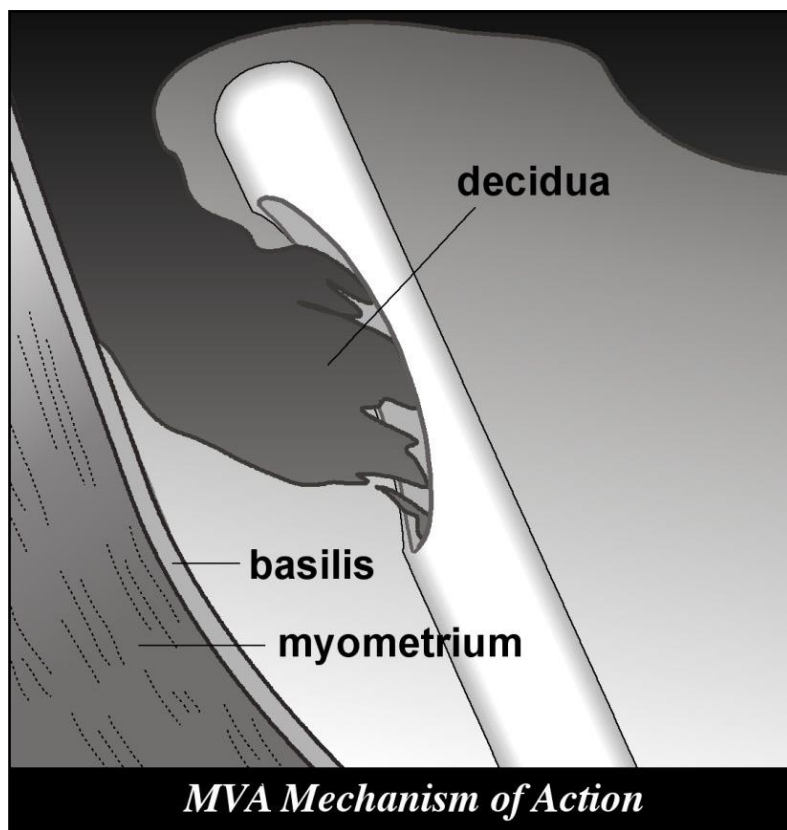
早期流産の手術法 “子宮内容除去術”

(2) 子宮内容搔爬術

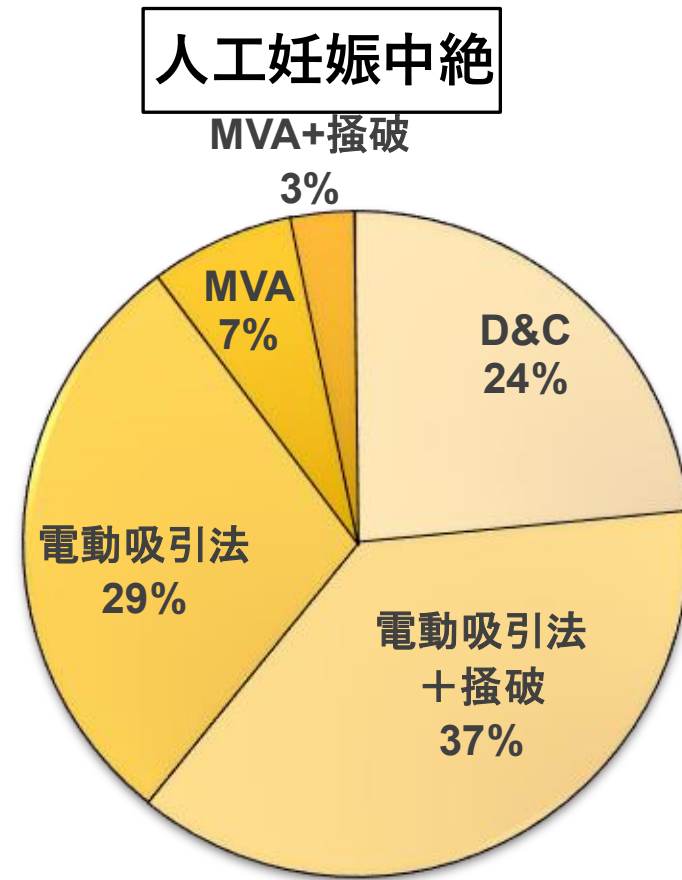
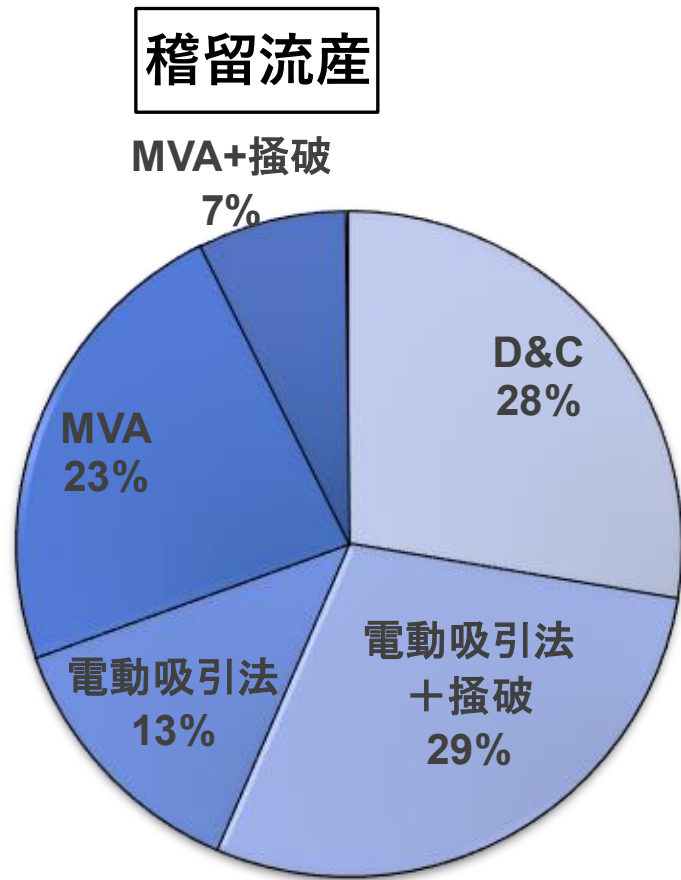
- 1、胎盤鉗子
- 2、吸引器
- 3、鈍搔、鋭搔



“子宮内容除去術” 吸引法 OR/AND D&C?

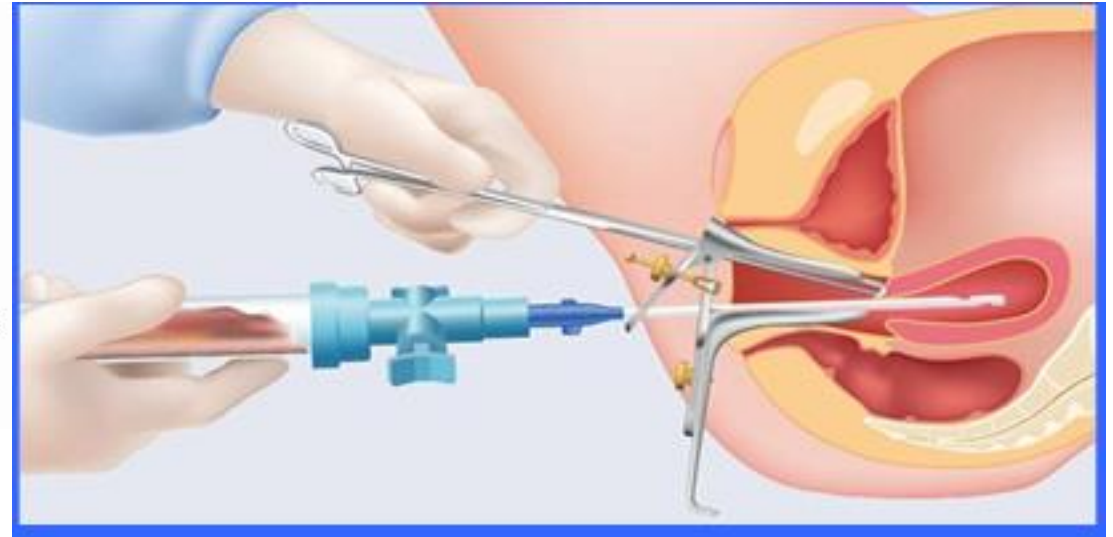


日本における流産手術の方法

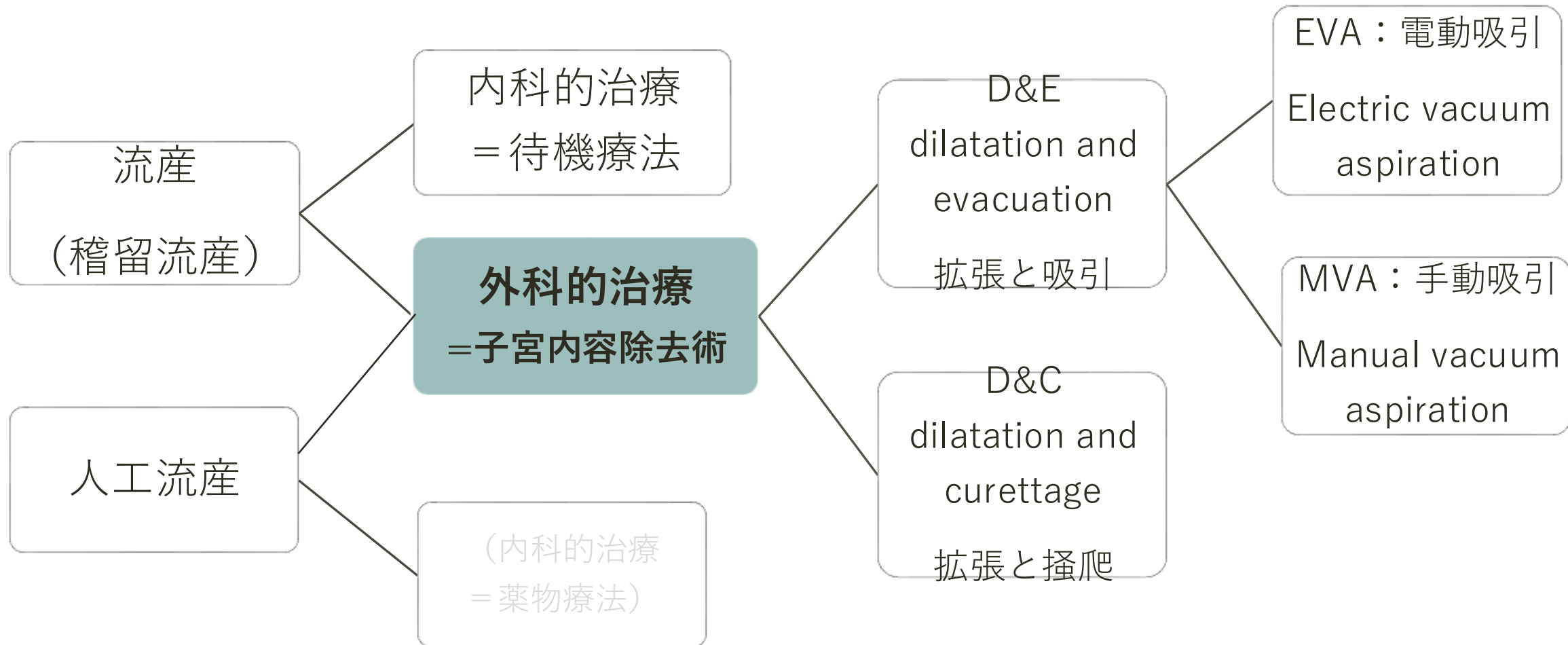


2019年における手術方法（日本産婦人科医会調査）
Nakamura et al., J. Obstet. Gynecol. Res. 2021.

MVA: Manual Vacuum Aspiration (手動真空吸引法)



早期（初期）流産の治療法



流産治療法の選択

外科的治療の合併症

- ①子宮穿孔
- ②子宮頸管裂傷

待機的管理の合併症

- ①予期せぬ出血
- ②子宮内容遺残による予定外の入院・手術
- ③胞状奇胎の診断遅延

	手術療法	待機的管理法
メリット	・早期に流産が解決できる ・日常生活への復帰の目処がつきやすい	・自然な回復が望める場合が多い ・手術および麻酔に関連したトラブルがない
デメリット	・手術や麻酔に対する恐怖と、処置に関連したトラブルが低頻度ながらある	・出血が大量となったり強い痛みを伴うことがある ・いつ自然排出が起きるか予想ができないので予定が立てにくい ・結局手術を必要とすることもある

流産手術時の麻酔

手術時間が短く(約5～15分以内)、疼痛レベルが比較的低い

⇒鎮静薬と鎮痛薬を組み合わせた**静脈麻酔** ±局所麻酔(傍頸管ブロック等)

鎮静薬の例：ベンゾジアゼピン系(ジアゼパム)、超短時間作用チオバルビタール
(チオペンタール, チアミラール)、プロポフォールなど

鎮痛薬の例：ペンタゾシン、フェンタニルなど

合併症として呼吸抑制が生じる可能性があり、

術中の血中酸素飽和度を含めたバイタルサインのモニタリングが重要

傍頸管ブロック



1%キシロカイン等
を用いた局所麻酔

後期(晩期)流産の手術法

“分娩誘発術”

(1) 子宮頸管拡張術 (→子宮頸管熟化)

(2) 薬物 (→頸管熟化 + 子宮収縮)

① プロスタグランジンE1経腔投与

(②プロスタグランジンF2 α 、オキシトシン)

人工妊娠中絶法

母体保護法

22週未満（妊娠21週6日まで）

—母体保護法に定められた適応条件—

母体保護法 第三章 母性保護

第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師（以下「指定医師」という。）は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によつまたは抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

薬物による早期人工妊娠中絶法

ミフェプリストン（別名RU-486）200mg 1錠内服

：抗プロゲステロン剤、子宮頸管熟化作用

↓ 36～48時間後

ミソプロストール800 μ g 4錠内服 ：子宮収縮作用

治験（妊娠9週0日まで）の結果

8時間後までに90%

24時間後までに93.3% 胎嚢が排出された

副作用

下腹部痛 30%、嘔吐 21%、重度の子宮出血（0.8%） など

2023年4月21日「子宮内妊娠が確認された妊娠9週0日以下の者に対する人工妊娠中絶」を効能効果として製造販売承認された

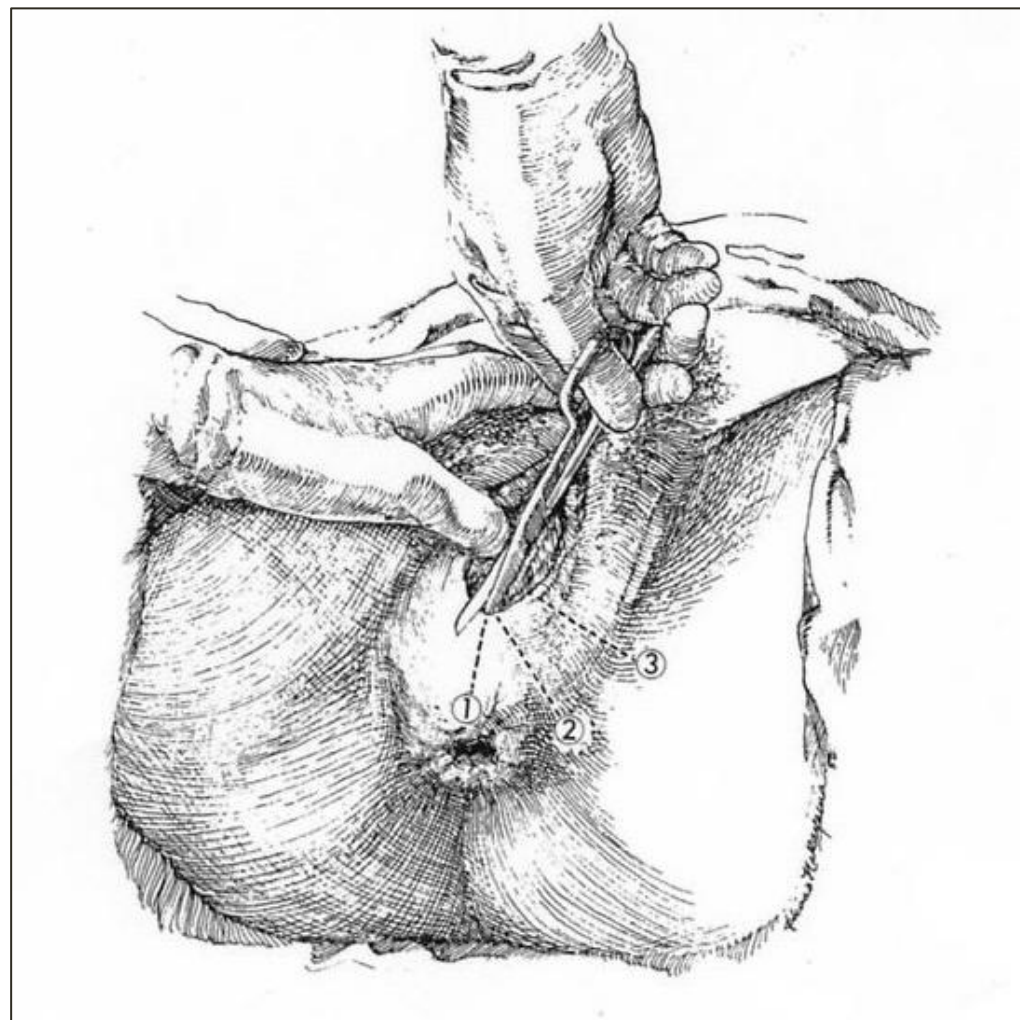
母体保護法指定医師の確認の下で投与を行う

周産期の手術法

妊娠22週0日以降の分娩に関わる手術

会陰切開術

- ① 正中切開術
- ② 正中側切開術
- ③ 側切開術



会陰裂傷

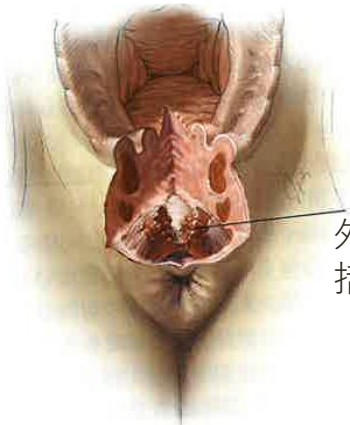


第1度会陰裂傷
表層性の損傷



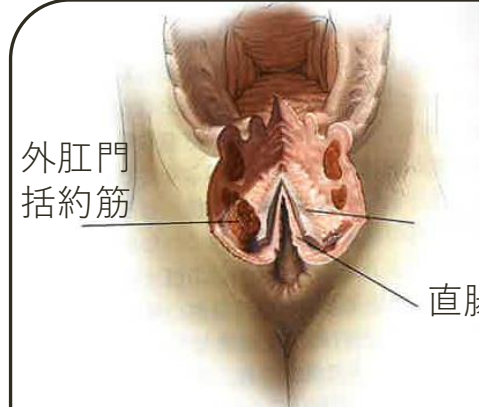
第2度会陰裂傷
筋層に及ぶもの

球海綿体筋
浅会陰横筋



第3度会陰裂傷
肛門括約筋に
及ぶもの

外肛門
括約筋

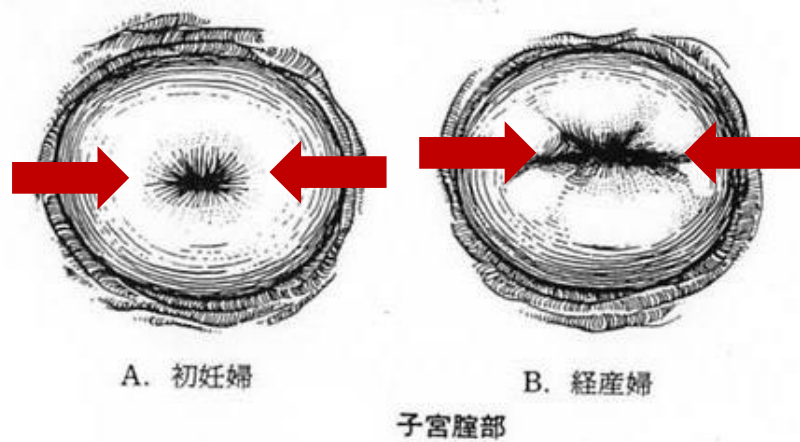


第4度会陰裂傷
直腸に及ぶもの

外肛門
括約筋

直腸粘膜

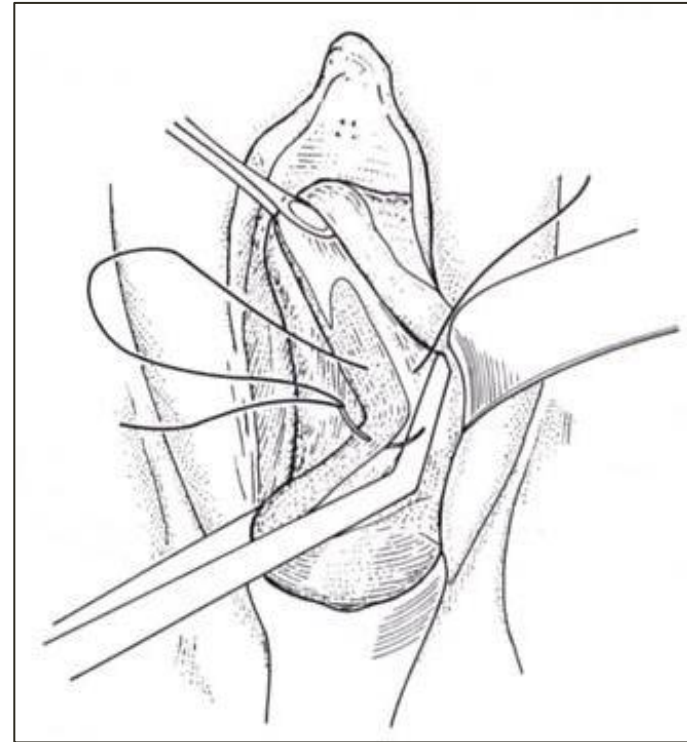
子宮頸管裂傷

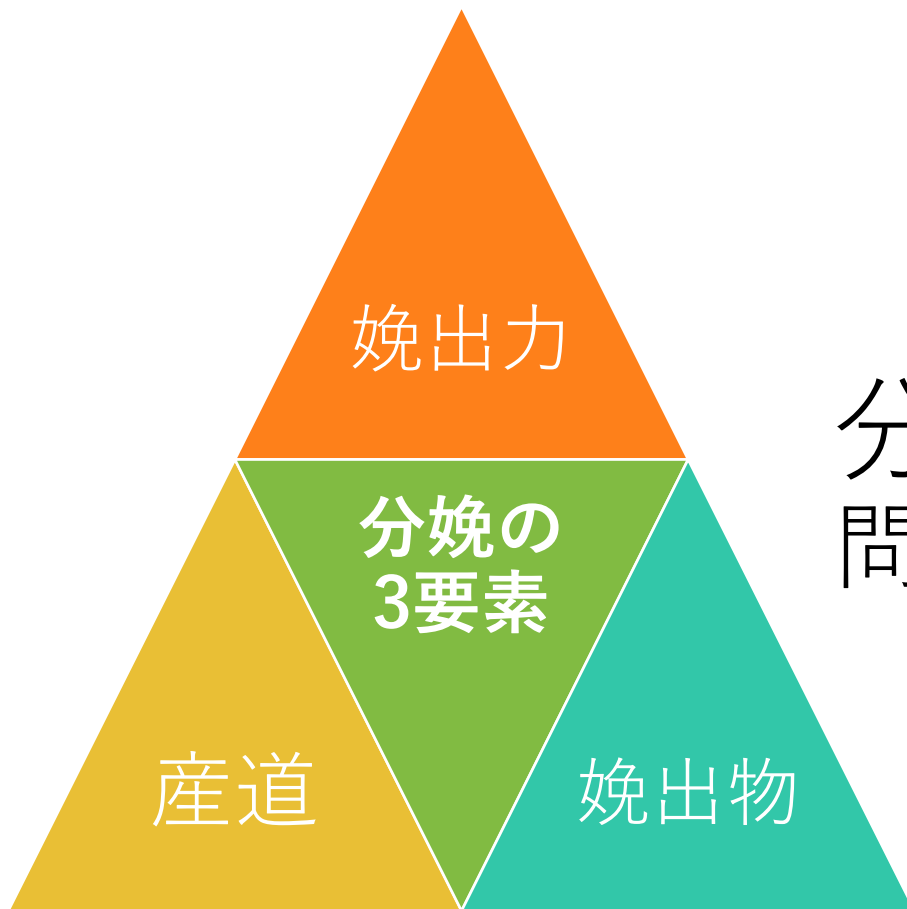


3時、9時の位置に発生しやすい



子宮動脈（下行枝）からの
出血に注意！





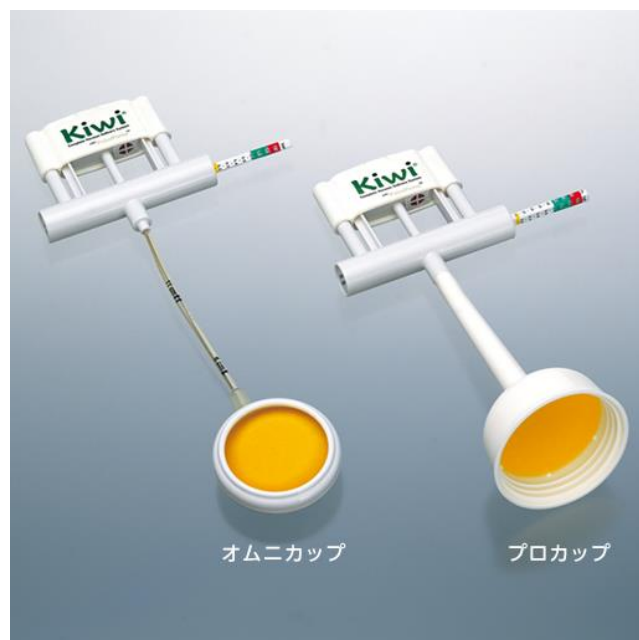
分娩の3要素に
問題が生ずると！



急速遂娩

- ・吸引分娩
- ・鉗子分娩
- ・帝王切開術

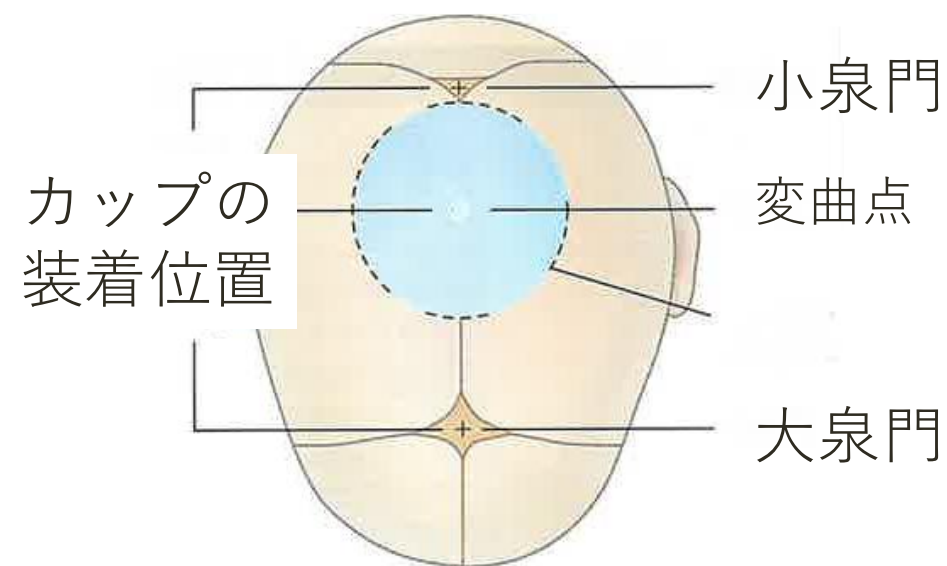
吸引分娩術



Kiwi 娩出吸引カップ



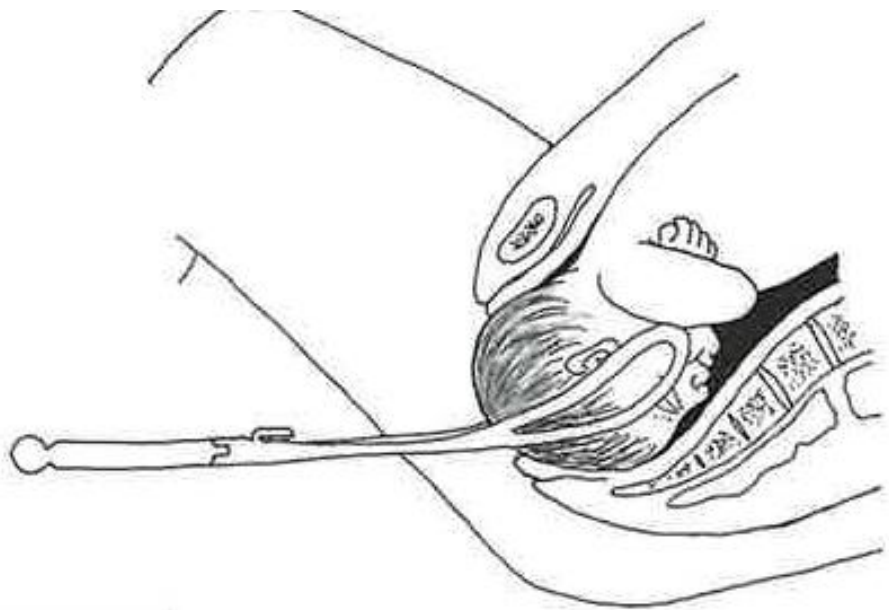
シリコンゴム製吸引カップ



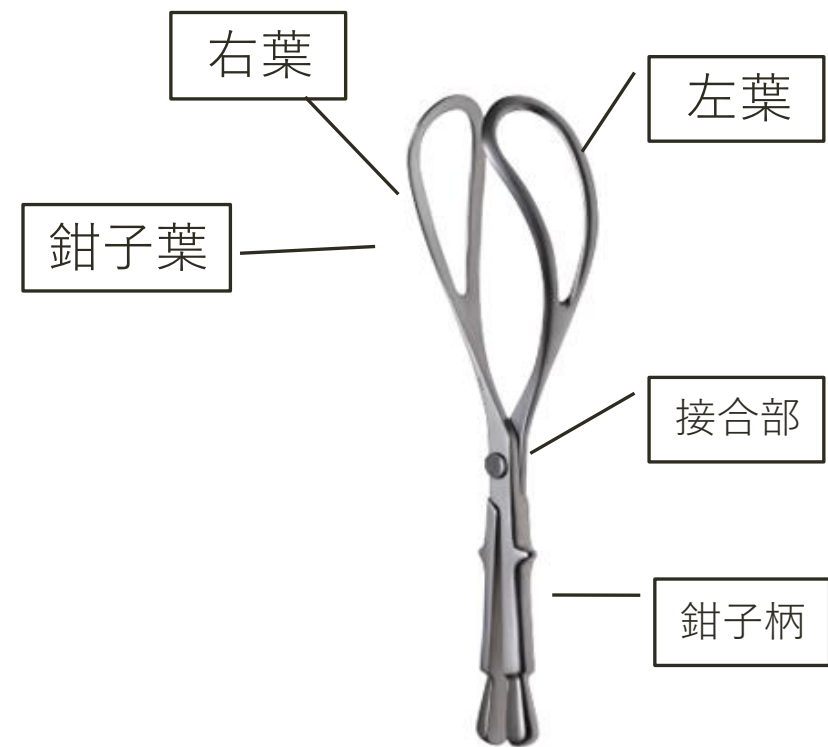
鉗子分娩術



正面図



側面図



よく用いられる産科鉗子



Simpson's forceps (1848)

- ・比較的小さい児頭彎曲
- ・遷延分娩-応形児頭を想定
- ・parallel shank



Elliot's forceps (1858)

- ・pressure regulating screw
- ・出口部児頭を想定
- ・日本では Naegele鉗子 のほうが普及



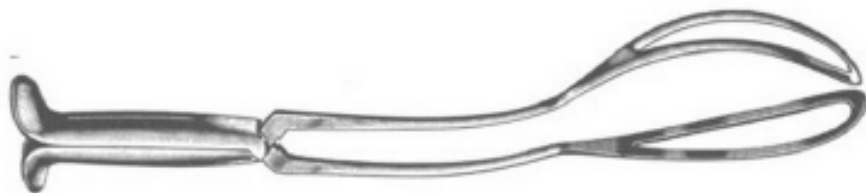
Tucker-McLane forceps (1885)

- ・solid blade
- ・小さい pelvic curve
- ・児頭への圧迫軽減と回旋操作が可能



Kielland's forceps (1916)

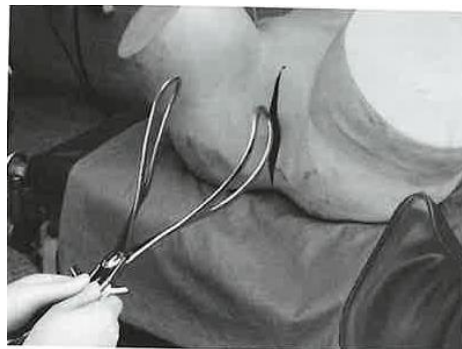
- ・小さい骨盤彎曲, 回旋を目的に開発
- ・sliding lock
- ・不正軸の修正



Piper's forceps (1924)

- ・骨盤位、後続児頭娩出用に開発

鉗子分娩術の実際



鉗子の疑持



左葉の挿入



右葉の挿入



鉗子の閉合



試験牽引



第1位への牽引
(後下方への牽引)



第2位への牽引
(水平下方への牽引)



第3位への牽引
(上方への牽引)

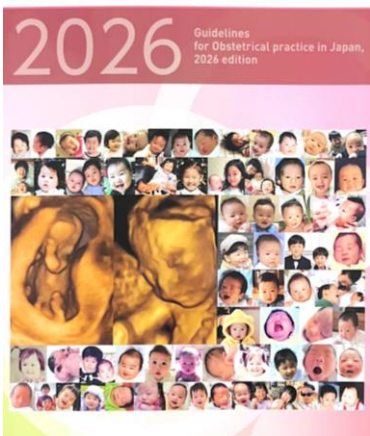


右葉、
左葉の抜去



CQ406 は？

産婦人科診療ガイドライン
産科編



吸引・鉗子娩出術の適応と要約、及び実施時の注意点

1. 急速遂娩が必要な状況で選択する可能性がある娩出方法について、あらかじめ妊婦へ説明しておく。（C）
2. 吸引・子娩出術および子宮底圧迫法は、**急速遂娩が必要な場合にのみ実施する**。（A）
3. 急速遂娩では子宮底圧迫法よりも吸引・鉗子娩出術を優先的に選択し、子宮底圧迫法は、牽引の娩出力の補助が必要な場合、
もしくは機器の準備に時間を要する場合など限定的な実施にとどめる。（A）
4. 吸引・鉗子娩出術、子宮底圧迫法は、以下のいずれかの適応を満たす場合に実施する。（B）
 - 1) 胎児機能不全（non-reassuring fetal status）.
 - 2) 分娩第2期遷延または分娩第2期停止.
 - 3) 母体合併症（心疾患など）または著しい母体疲労のため、分娩第2期短縮が必要と判断した場合.
5. 実施に先立ち内診を実施して産道内の児頭下降と児頭回旋の状態の把握を行う.
6. 産道内の児頭下降と児頭回旋の判断の精度向上のために必要に応じて超音波検査を用いた評価法を行う。（C）
7. 実施に際しては以下の要件を満たしていることを確認する.
 - 1) 吸引娩出術では、妊娠34週以降.（C）
 - 2) **子宮口全開大かつ既破水.**（B）
 - 3) 産道内の児頭下降と児頭回旋の状態から娩出が見込める（表1参照）（B）

表1

	鉗子娩出術	吸引娩出術	子宮底圧迫法を単独で実施する場合
ステーション	+2以上に下降	+2以上に下降	+4以上に下降
児頭最大周囲径の位置	原則、低い中在（中位） もしくはそれより低位	児頭が十分に陥入している（少なくとも低い中在以下）	低在，出口部
児頭第2回旋の状態	矢状縫合が縦径に近い（母体前後径と児頭矢状径のなす角度が45度未満）	条件なし	条件なし

吸引・鉗子娩出術における 児頭下降度の目安

Station-1 より高い
場合は吸引・鉗子
はできない！

児頭固定＝内診・外診で児頭を押し上げることができない状態。
ステーション-2より下降

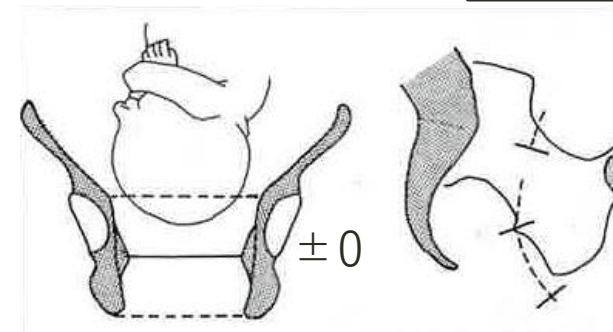
児頭**陥入**＝児頭がステーション±0
(坐骨棘の高さまで先進部が下降)

吸引分娩は
Station ± 0

鉗子分娩は
Station + 2

我が国の児頭最大周囲系の 位置による分類	ステーション分類 (センチメートル)
中在（中位）鉗子	(+1) +2 (+3)
低在（低位）鉗子	+3~+4
出口部鉗子	+5

より
安全
安心



吸引・鉗子分娩の合併症

母体

軟産道（会陰・腔壁裂傷）損傷、膀胱麻痺、
膀胱損傷、直腸損傷

児

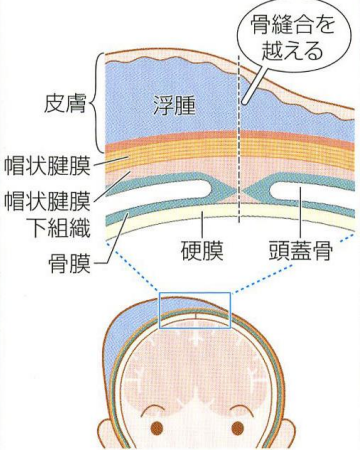
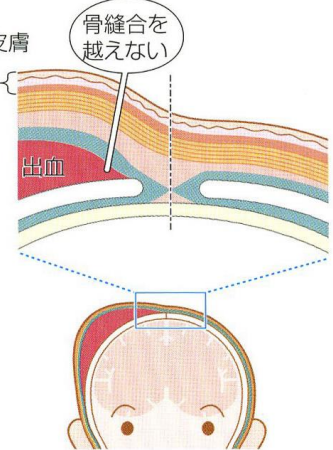
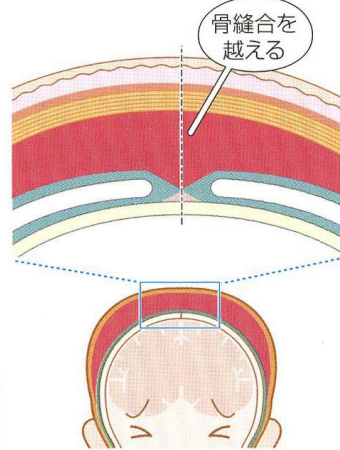
産瘤（吸引分娩をしなくてもできることがある）

圧迫痕

頭血腫、帽状腱膜下血腫（出血多量で重症となる場合があるが、吸引分娩中の発生頻度は1%で稀）

頭皮損傷、頭蓋骨骨折、頭蓋内出血、眼球・角膜損傷、耳損傷、
外傷性顔面神経麻痺

産瘤・頭血腫・帽状腱膜下血腫の鑑別

	産 瘤	頭血腫	帽状腱膜下血腫
発 生	- 分娩時の産道抵抗による圧迫で浸出液が貯留する。 - 出生直後より著明。	- 狭骨盤、吸引・鉗子分娩により骨膜が頭蓋骨から剥離する。 - 生後徐々に大きくなる。	吸引分娩などにより帽状腱膜と骨膜が剥離する。
構造と特徴	 - 波動性なし。容易に圧入される。 - 境界不明瞭 - 先進部に1個のみ	 - 波動性あり - 境界明瞭 2個以上のこともある	 - 波動性あり - 境界不明瞭 - 血腫が前額、眼瞼、耳介周囲におよぶことがある。
消失時期	24～36時間	生後数週～数カ月	生後1～2カ月
処 置	経過観察		大量出血に対する処置 - 輸血 - 出血性疾患の検索
備 考	第1胎向では右頭頂骨後部に、第2胎向では左頭頂骨後部にできる（児頭先進部前在側に形成）。	- 高ビリルビン血症を伴うことがある。 - 吸収されなかった血液は石灰化する。	高度貧血、高ビリルビン血症を伴い、出血性ショック、DICから死に至ることがある。

▶ 産瘤、頭血腫の穿刺は、感染の危険性が高いため原則として行われたい。

帝王切開術

日本における帝王切開数

約12万人

1990年



約18万人

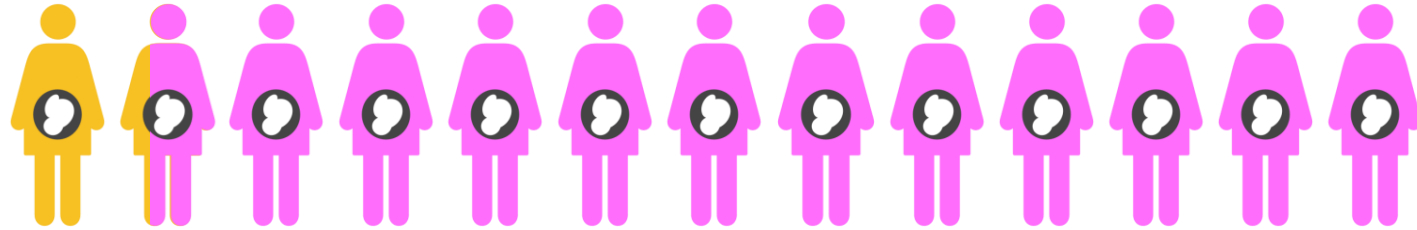
2020年



日本における帝王切開数

約12万人

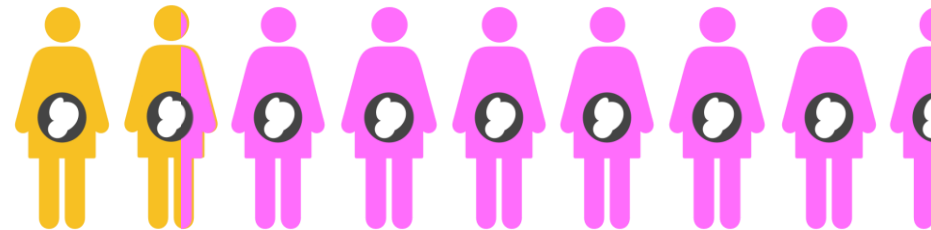
1990年



出生数122万人

約18万人

2020年



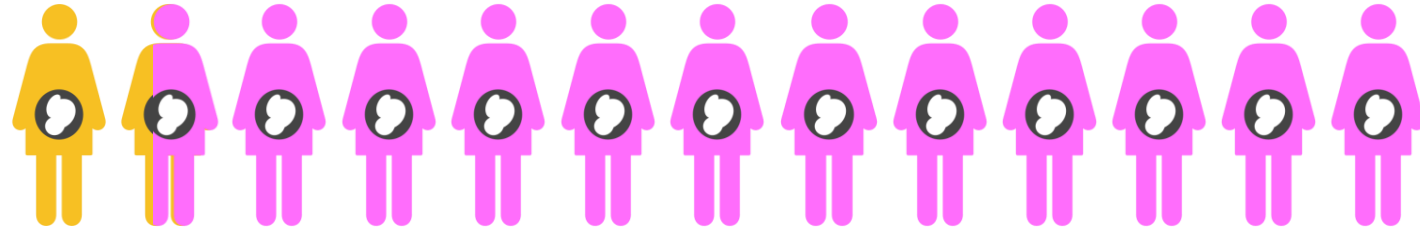
出生数85万人



日本における帝王切開率

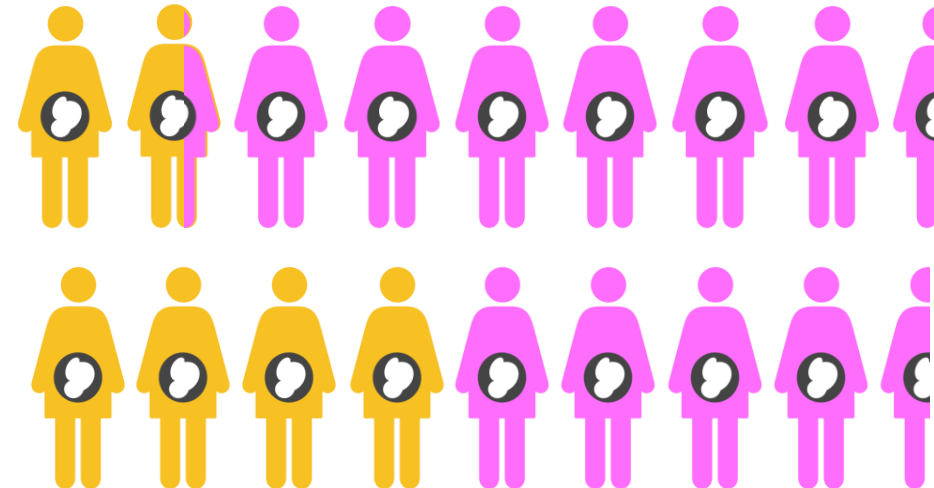
10% (10人に1人)

1990年



22% (5人に1人)

2020年

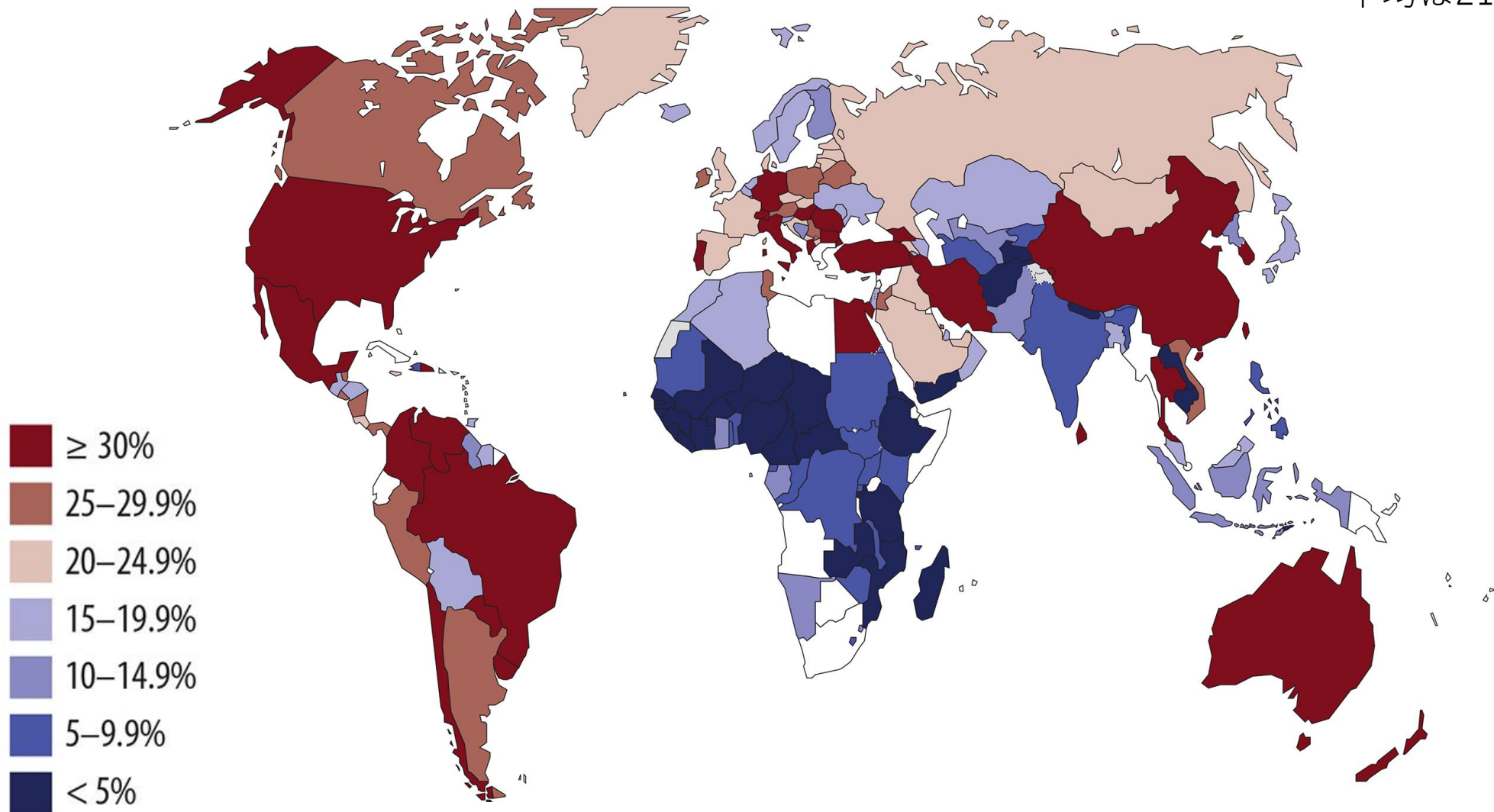


日本の帝王切開率は、
30年間で2倍増加している!!

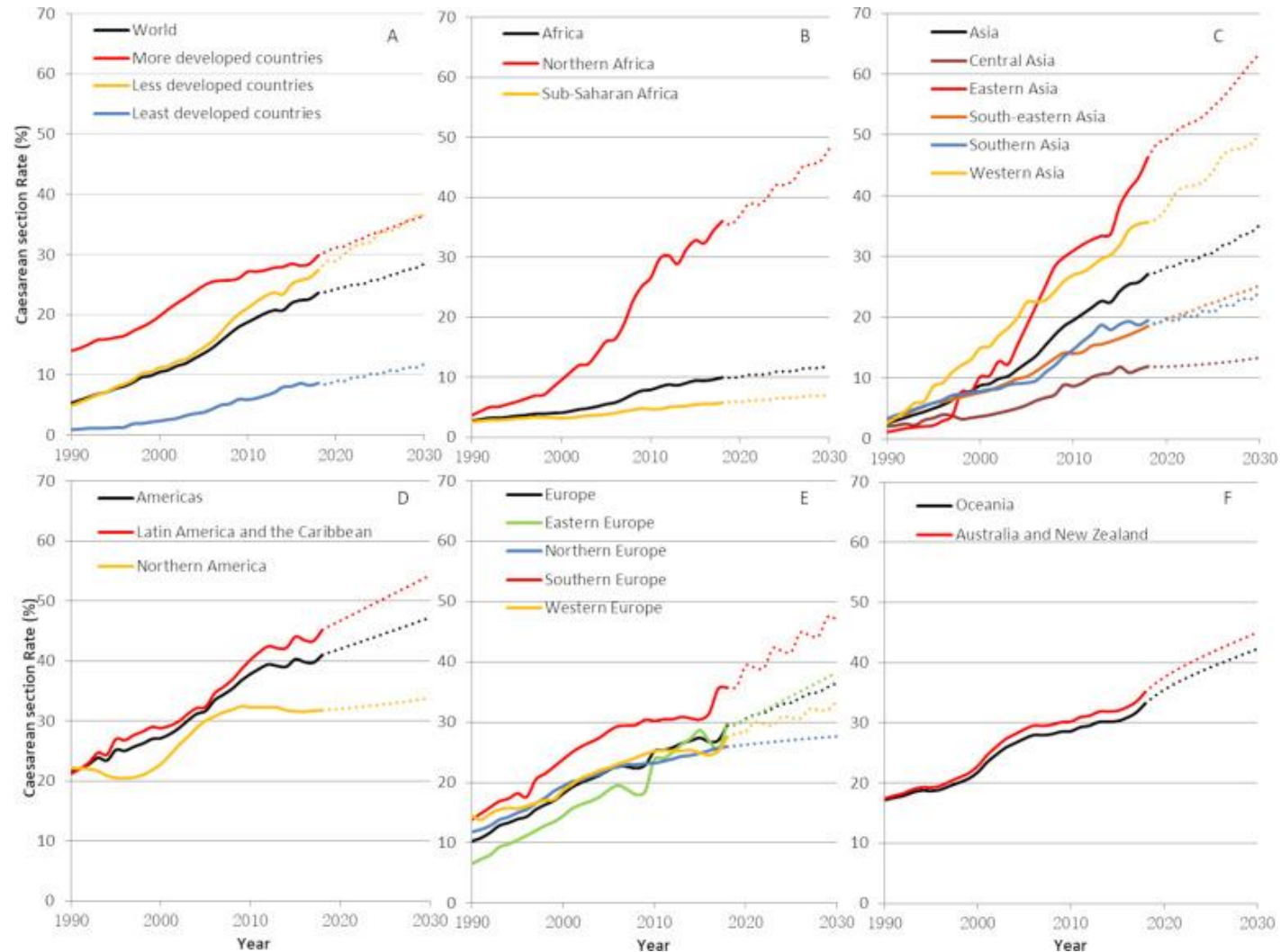
40%(名市大)

世界の帝王切開率

平均は21.1% (2018年)



世界の帝王切開率の推移



帝王切開ってどんな手術？

麻酔下で

①下腹部を横切開もしくは縦切開



②子宮切開



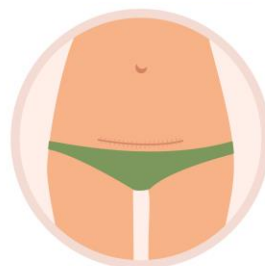
③赤ちゃんを取り出す



④胎盤を取り出す

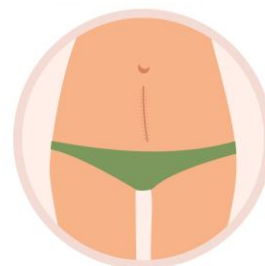
ここまで
わずか1分の場合も！

皮膚切開には2種類



ヨコ

整容性に
優れる

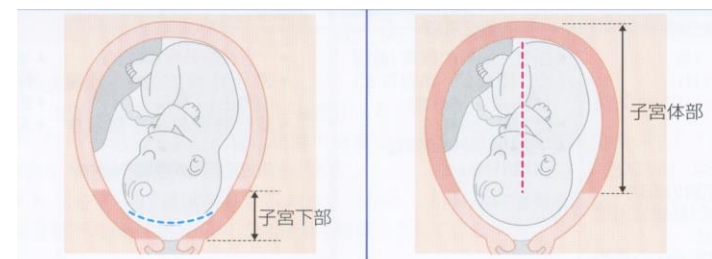


タテ

視野が取りやすい
早く腹腔内に到達可

皮膚の切開方向と子宮の切開方向は
必ずしも同じではない

子宮切開も2種類



ヨコ

(子宮下部横切開

タテ

(古典的縦切開)

通常はこちらが
選択される



帝王切開ってどんな手術？



手術時間は
約30分～1時間程度

赤ちゃんが出たら、

- 子宮を縫合する
- 腹壁（腹膜、筋膜、皮下組織）の縫合
- 皮膚表面は縫合せずテープなどで合わせることが多い（抜糸や抜鉤不要）
- 術後創部の管理（ケロイド予防）

帝王切開が必要になるのはどんな時？

経膣分娩が不可能、もしくは
経膣分娩が危険だと判断される時

母体と胎児に危険が迫っている時

お母さんと赤ちゃんのピンチを救うのが帝王切開術なのです！

帝王切開が必要になるのはどんな時？

経膣分娩が不可能、もしくは
経膣分娩に危険が伴う時

- ・ 分娩停止
 - ・ 前置胎盤、低置胎盤
 - ・ 児頭骨盤不均衡
 - ・ 既往子宮術後妊娠
 - ・ 胎位の異常（逆子など）
 - ・ 回旋異常
 - ・ 多胎
- …など

選択的帝王切開術

出産予定日(40週0日)の2～3週間前
(37～38週頃)に行うことが多い

母体と胎児に危険が迫っている時

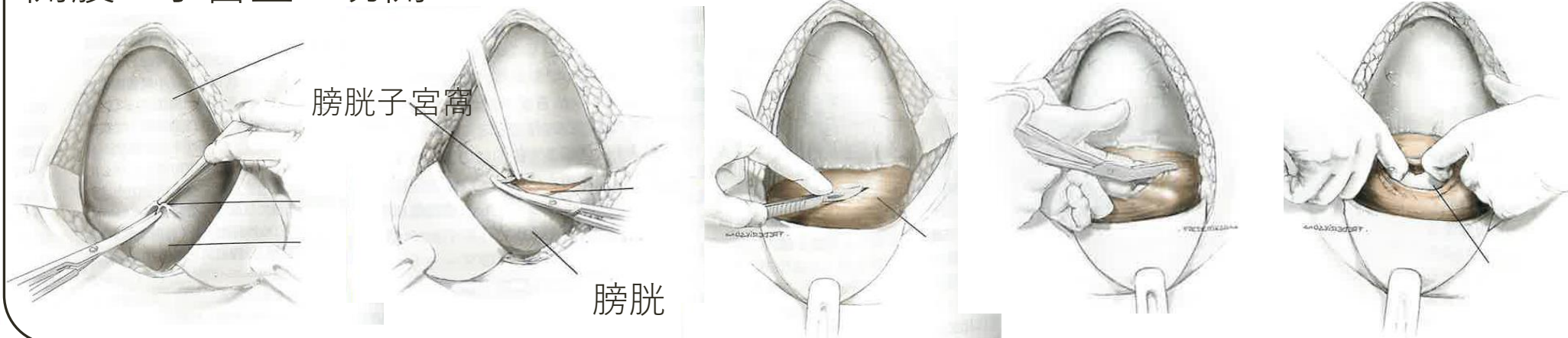
- ▶ 胎児機能不全・胎児仮死
 - ▶ 常位胎盤早期剥離
 - ▶ 妊娠高血圧症候群
- …など

緊急帝王切開

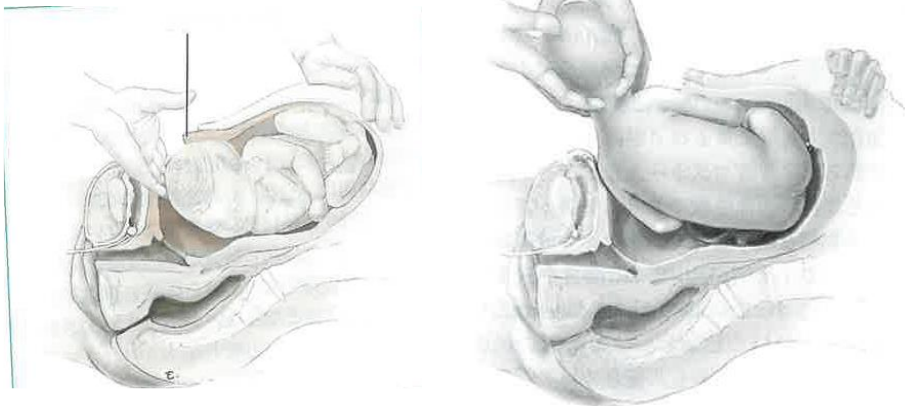
当日の状況で突然決まる

帝王切開術の手順

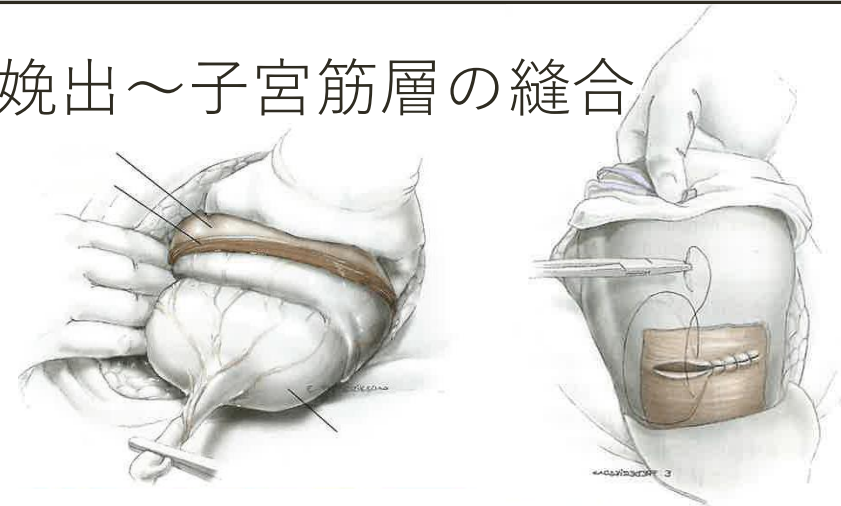
開腹～子宮壁の切開



児の娩出



胎盤の娩出～子宮筋層の縫合



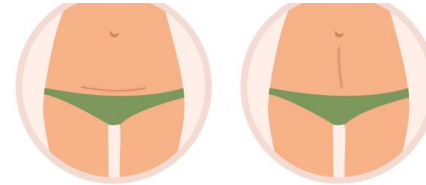
帝王切開の手順

麻酔下で

- ①下腹部皮膚を横切開もしくは縦切開
- ③皮下組織、筋膜切開
- ②膀胱子宮窩腹膜切開
- ③子宮筋層切開＋鈍的開大
- ④胎児娩出
- ⑤胎盤娩出
- ⑥子宮筋層縫合
- ⑦腹壁（筋膜、皮下組織）縫合



皮膚切開は2種類



横切開

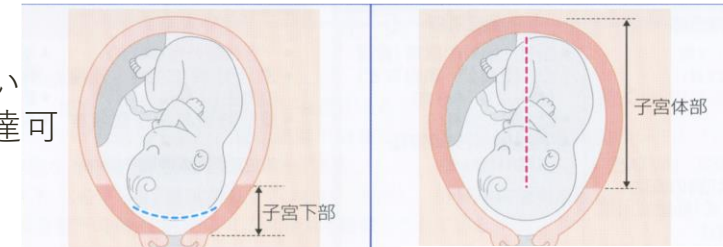
整容性に
優れる

縦切開

視野が取りやすい
早く腹腔内に到達可

皮膚の切開方向と子宮の切開方向は
必ずしも同じではない

子宮切開も2種類

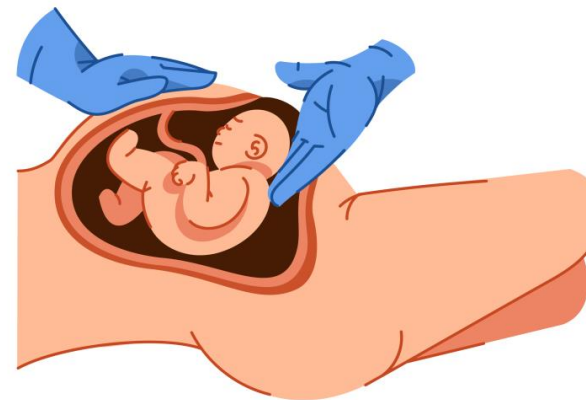


子宮下部横切開

通常はこちらが
選択される

古典的縦切開

ここまで
わずか1分の場合も！



手術時間は
約30分～1時間程度

帝王切開術のKey Words

cesarean section(英)
Kaiserschnitt(独)

“適応”と“要約”

帝王切開術のKey Words

“適応”

その状況によくかなうこと。

相応しいこと。

あてはまること。

“要約”

契約をすること。

約束ごと。

帝王切開術の適応

予定（選択的）帝王切開

母体適応

前置胎盤、狭骨盤、児頭骨盤不均衡、多胎妊娠、感染症、
既往帝王切開術後、子宮筋腫核出術後、軟産道強靱、頸部筋腫、
合併症妊娠（腎疾患、心疾患など）

Q、妊娠何週位で帝王切開
術の予定をたてますか？

- ① 36週
- ② 37-38週
- ③ 40週（予定日越えてから）

胎児適応

胎位・胎勢異常（骨盤位、横位、反屈位など）、巨大児、
子宮内胎児発育遅延

帝王切開術の適応

緊急帝王切開

母体適応

子宮破裂徴候、遷延分娩、分娩停止、重症妊娠高血圧症候群、
出血を伴う前置胎盤、常位胎盤早期剝離



産科DIC

胎児適応

胎児機能不全（胎児ジストレス）、臍帯下垂・脱出、
常位胎盤早期剝離

帝王切開術の要約

以下の条件を満たしていない場合は、
帝王切開術を行ってはならない。

母体

手術に耐えうること。

胎児

生存しており、胎外生活が可能であること。

死戦期帝王切開術

※胎児・胎盤の存在が母体の生命に危険を及ぼす場合は、**児の生死を問わない。**

帝王切開術の麻酔法

妊婦は横隔膜が挙上しており
誤嚥性肺炎や挿管困難等、
母体の致命的合併症の発生頻度
が高い

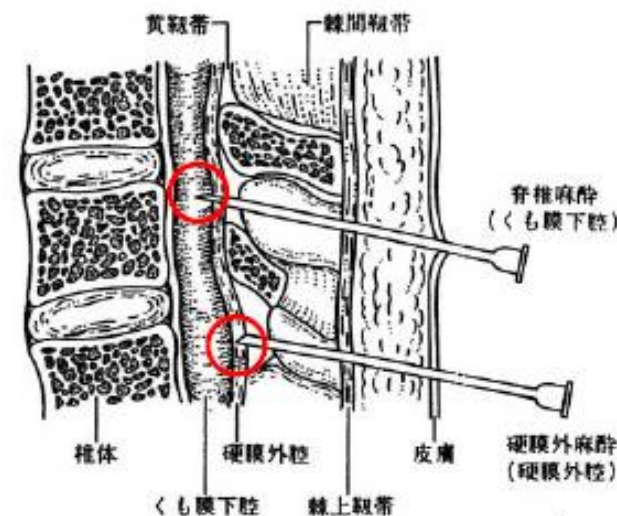
予定（選択的）帝王切開術、準緊急帝王切開術

- 脊髄くも膜下麻酔
- 硬膜外麻酔

（超）緊急帝王切開術、合併症、抗凝固療法使用時

- 全身麻酔

※全身麻酔のメリットは迅速性



産科麻酔法

局所麻酔・脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔

一般名	商品名	使用濃度	作用発現までの時間	効果持続時間 (分)
リドカイン Lidocaine	キシロカイン	1~2%	早い	60~90
メピバカイン Mepivacain	カルボカイン	1~2%	早い	60~90
プピバカイン Pupivacaine	マーカイン	0.25~0.5%	中間	60~180
ロピバカイン Ropivacaine	アナペイン	0.25~0.5%	中間	60~180

脊髄くも膜下麻酔や硬膜外麻酔では局所麻酔薬に少量の麻薬（フェンタニル、モルヒネ）を併用することで術中・術後の麻酔効果が向上する

脊髄くも膜下麻酔による帝王切開

交感神経遠心線維

1－3分

毛細血管が拡張し下肢が温かくなった感じを自覚

知覚神経（C線維）

3－5分

緩やかな温度変化に対する近くがブロックされる（アルコール綿の冷たさを感じなくなる）

知覚神経（A δ 線維）

5－10分

侵害受容刺激（痛覚や急な温度変化）に対する知覚がブロックされる

知覚神経（A β 線維）

触覚や深部知覚がブロックされる（完全にはブロックされないこともある）

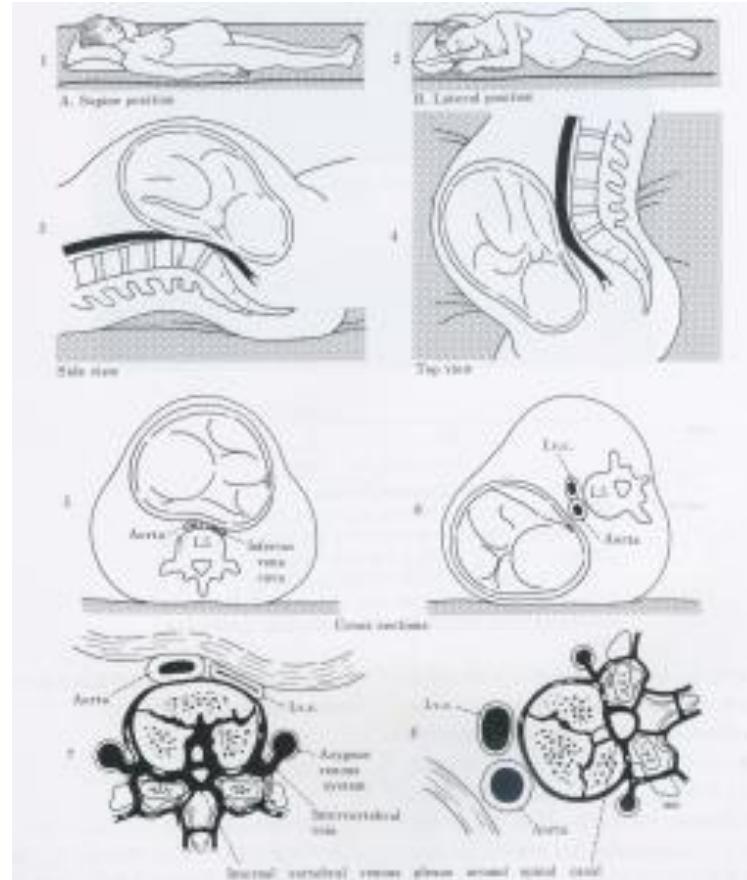
帝王切開の麻酔の問題点 仰臥位低血圧症候群

原因

妊娠子宮による下大静脈の圧迫

対策

- ①左側臥位（左下）
- ②約30%の傾斜
- ③タオル等使用



妊婦の心肺蘇生



薬物を使わない産痛緩和の方法

- ✓呼吸法
- ✓アロマセラピー、リフレクソロジー（リラックス法）
- ✓温める、水中出産
- ✓腰を押す、マッサージ
- ✓指圧、鍼
- ✓心理学的方法

硬膜外無痛分娩

日本の硬膜外無痛分娩率

2007年 2.6%

2016年 6.1%

2023年 13.8%

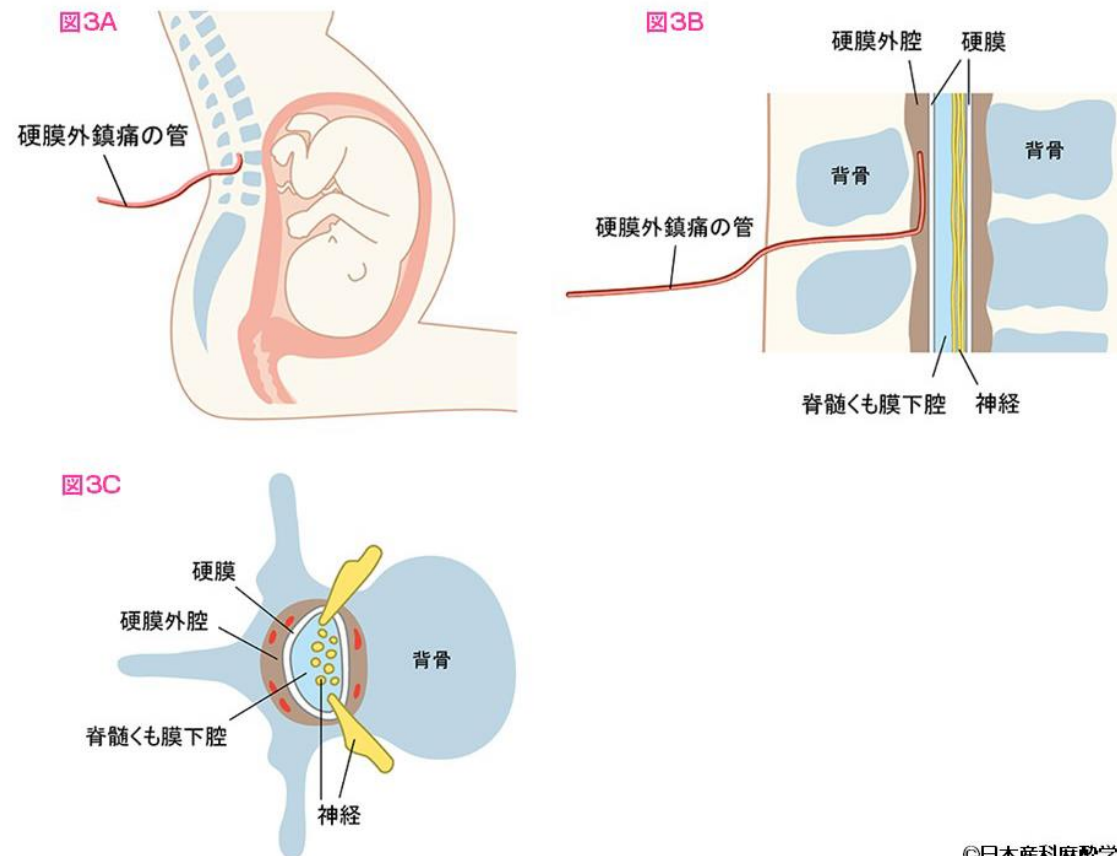
海外での硬膜外無痛分娩率

アメリカ 73.1% (州によって異なる)

フランス 82.2%

図3. 硬膜外鎮痛

図3Aに、お母さんの背中に入った硬膜外鎮痛の管を示します。
管の付近を拡大したものが図3Bです。図3Cは背骨の断面像です。



©日本産科麻酔学会

硬膜外分娩の利点・欠点

利点

- 痛みが和らぐ
- 母体ストレスホルモンの減少
- 過換気などの赤ちゃんへの悪影響を防ぐ
- 分娩ストレスに耐えられない「持病」がある場合の補助
- 他の鎮痛方法と比べて、胎児への麻酔薬の移行が少ない

欠点

- 分娩時間（第1期、第2期）が長くなることもある
- 吸引・鉗子分娩となる確率が上がる
- 麻酔合併症が発生する可能性がある
- 食事や歩行に制限がある
- 熱が出ることがある
- 費用がかかる

硬膜外麻醉で注意すべき合併症

●麻酔合併症

- ・ 低血圧
- ・ 高位麻酔、全脊麻
- ・ 局所麻酔中毒

●産科合併症

- ・ 産科危機的出血（弛緩出血、子宮型羊水塞栓症）
- ・ 子宮破裂

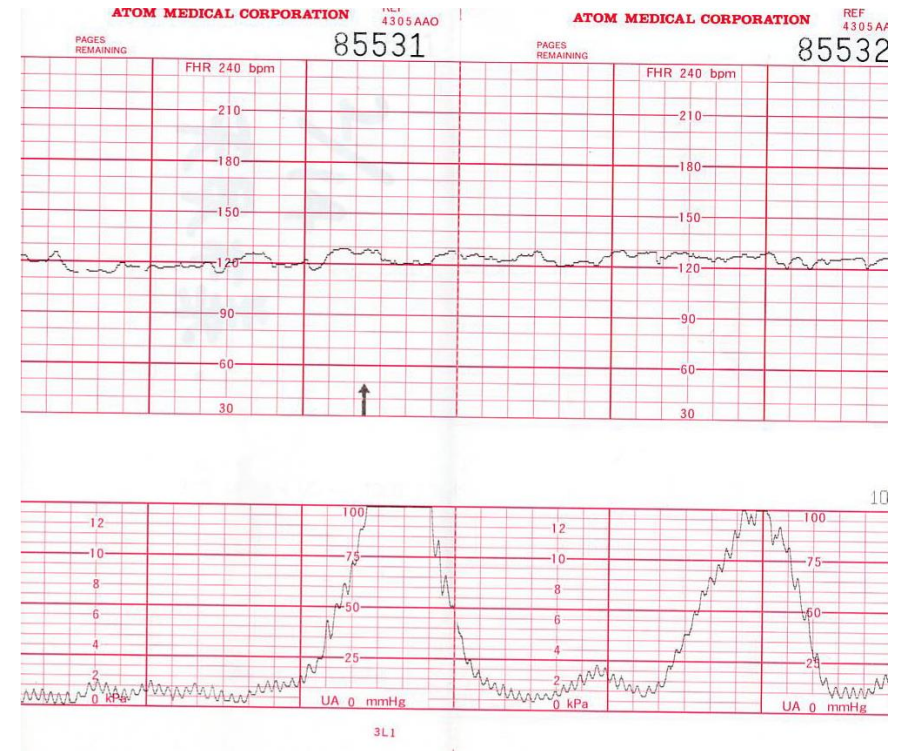
硬膜外麻酔（無痛分娩）の問題点

妊婦さんの‘腹圧’

陣痛と腹圧が調和しない！



吸引・鉗子分娩の頻度が**増加**する



帝王切開術の適応

予定（選択的）帝王切開

母体適応

前置胎盤、狭骨盤、児頭骨盤不均衡、多胎妊娠、感染症、
既往帝王切開術後、子宮筋腫核出術後、軟産道強靱、頸部筋腫、
合併症妊娠（腎疾患、心疾患など）

胎児適応

胎位・胎勢異常（骨盤位、横位、反屈位など）、巨大児、
子宮内胎児発育遅延

帝王切開をしたら次回出産時も必ず帝王切開が必要？

既往帝王切開後妊娠の妊婦さんが経膈分娩をトライすること

TOLAC（トーラック）

Trial Of Labor After Cesarean Section

経膈分娩を“試みる”

VBAC（ブイバック）

Vaginal Birth After Cesarean section

帝王切開術後に経膈分娩に成功した

子宮破裂のリスク

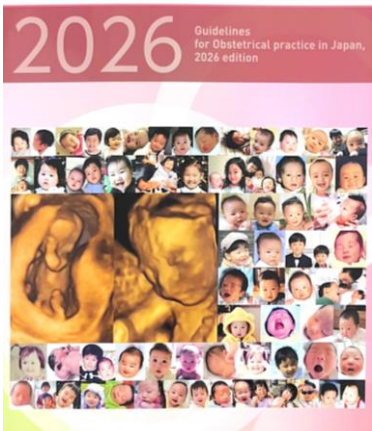
TOLAC：0.2～0.7%（約1%）

非瘢痕子宮：約0.05%

99%の帝王切開術後妊婦は子宮破裂を起こさない

産婦人科診療ガイドライン
産科編 日本産科婦人科学会／日本産婦人科医会

CQ403 既往帝王切開妊婦が経膈分娩（TOLAC）を希望した場合は？



2. TOLACを行う際には、以下の項目を満たしていることを確認する。
- 1) 緊急帝王切開および子宮破裂に対する緊急手術が可能である。
 - 2) 既往帝王切開以外の子宮腔内に達する手術既往がない。
 - 3) 子宮破裂の既往がない。
 - 4) 既往帝王切開術式が子宮下節横切開である。
 - 5) 既往帝王切開数が1回である。
 - 6) 既往帝王切開術後経過が良好であった。



CQ403

既往帝王切開妊婦が経腔分娩（TOLAC）を希望した場合は？

産婦人科診療ガイドライン

産科編 第2版 改訂
日本産科婦人科学会・日本産婦人科医学会

2026 Guidelines for Obstetrical practice in Japan, 2026 edition



1. TOLACとともに緊急帝王切開に関しても、あらかじめ実施による利益と危険性について、文書による説明と同意を取得する. (A)
2. TOLACを行う際には、以下の項目を満たしていることを確認する.
 - 1) 緊急帝王切開および子宮破裂に対する緊急手術が可能である. (A)
 - 2) 既往帝王切開以外の子宮腔内に達する手術既往がない. (B)
 - 3) 子宮破裂の既往がない. (B)
 - 4) 既往帝王切開術式が子宮下節横切開である. (A)
 - 5) 既往帝王切開数が1回である. (B)
 - 6) 既往帝王切開術後経過が良好であった. (C)
3. 分娩誘発あるいは陣痛促進の際に、プロスタグランジン製剤（プロスタグランジンF_{2α}製剤，プロスタグランジンE₂製剤〔経口剤〕，プロスタグランジンE₂製剤〔腔用剤〕〔プロウペス®〕）を使用しない. (A)
4. 試験（経腔）分娩中は、分娩監視装置による胎児心拍数の連続モニタリングを行う (A)
5. 経腔分娩後は子宮破裂に留意し、母体のバイタルサイン（shock indexなど）の変化と下腹痛の有無を観察する. (B)

帝王切開術の合併症

母体

麻酔によるもの

脊麻ショック、誤嚥性肺炎

術中操作によるもの

出血、臓器損傷（膀胱、尿管、腸）

術後合併症

産褥熱

深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症

術後イレウス

縫合不全

次回妊娠・分娩への影響

帝王切開の反復・子宮破裂

子宮破裂

前置胎盤

癒着胎盤

児

麻酔薬の移行（全身麻酔の場合）、母体低血圧による影響

新生児一過性多呼吸

児損傷

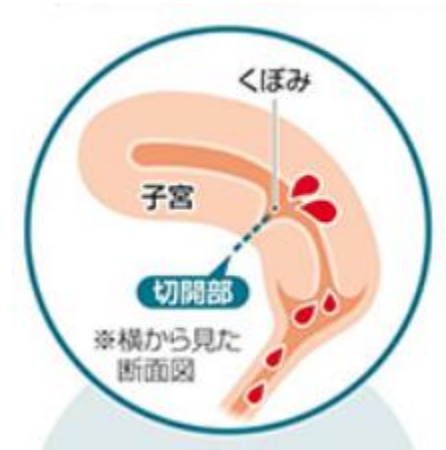
帝王切開癒痕部症候群

帝王切開術で切開した子宮の筋肉どうしがうまく癒合せずくぼみとして子宮に残る病態。

過長月経、不正性器出血（主に月経終了後に茶色の粘性の高い帯下が長引くことが多い）、月経困難症、慢性の骨盤痛、不妊症などを引き起こす。

国内では年間2～3万人が新たに発症するとの推計もあるが、認知度が低く見過ごされている人が多い可能性がある。

治療：ホルモン療法、手術療法



ヨミドクター2024年1月20日記事より改変
<https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20240109-OYTET50031/>

超緊急帝王切開術

	許容時間	麻酔の方法
A	直ちに（20-30分以内）	全身麻酔
B	1時間以内	脊髄くも膜下麻酔
C	数時間以内	脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔
D	予定	脊髄くも膜下麻酔、硬膜外麻酔

参考資料

- ・産婦人科診療ガイドライン産科編2026(日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会)
- ・日本産婦人科医会研修ノートNo.99流産のすべて
- ・ウィリアムス産科学原著25版（南山堂）
- ・病気がみえるVol.10（Medic Media）
- ・119番周産期救急対応・搬送ガイドブック（中山書店）
- ・分娩介助学（医学書院）
- ・プリンシプル産科婦人科学第3版（メジカルビュー社）
- ・産科麻酔ポケットマニュアル（羊土社）